

GLUCOSE 10%

- * Thành phần:** Công thức bào chế cho 100 ml thành phẩm:
Glucose monohydrat tương đương glucose khan 10 g
Nước cất pha tiêm vô 100 ml
- * Dạng bào chế:** Dung dịch tiêm truyền
- * Qui cách đóng gói:** Chai 500 ml, chai 250 ml, thùng 20 chai 500 ml, thùng 30 chai 250 ml.
- * Dược lực học:**
 - Glucose là đường đơn 6 carbon, dùng để điều trị thiếu hụt đường và dịch. Glucose thường được dùng cùng với các dung dịch điện giải để phòng và điều trị mất nước do tiêu chảy cấp. Glucose còn được sử dụng để điều trị chứng hạ đường huyết và được sử dụng làm chất vận chuyển các thuốc khác.
- * Dược động học:**
 - Glucose chuyển hóa thành carbon dioxide, nước và đồng thời giải phóng ra năng lượng.
- * Chỉ định:**
 - Phòng và điều trị hạ đường huyết
 - Mất nước hoặc mất nước kèm theo có nhu cầu cao carbohydrat.
 - Cung cấp năng lượng trong chế độ dinh dưỡng lâm sàng.
 - Dùng để pha loãng các sản phẩm thuốc tương thích.
- * Liều dùng, cách dùng:**

Liều dùng

Liều dùng và tốc độ truyền của Glucose 10% phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm: chỉ định sử dụng, lứa tuổi, cân nặng, tình trạng lâm sàng.

Người lớn và người cao tuổi:

Chỉ dẫn liều dùng cho người có cân nặng trung bình (70kg)(*)

Chỉ định	Liều dùng ban đầu	Tốc độ truyền	Khoảng thời gian điều trị
Cung cấp năng lượng trong chế độ dinh dưỡng lâm sàng.	Từ 500 ml đến 3000 ml/ngày (từ 7 ml/kg đến 40 ml/kg/ngày)	Tốc độ truyền khuyến cáo tối đa không được vượt quá quá trình oxy hóa glucose của bệnh nhân, vì điều này có thể gây tăng đường huyết: 5 mg/kg/phút (3 ml/kg/giờ)	Không giới hạn về thời gian điều trị - tùy thuộc vào tình trạng lâm sàng của người bệnh.
Phòng và điều trị hạ đường huyết			
Mất nước hoặc mất nước kèm theo có nhu cầu cao carbohydrat			
Dùng để pha loãng các sản phẩm thuốc tương thích	Từ 50 đến 250 ml trên liều dùng	Tùy thuộc vào thuốc pha loãng cùng	Tùy thuộc vào thuốc pha loãng cùng

*Thế tích lớn nhất trong liều khuyến cáo nên dùng trong 24 giờ để tránh chứng loãng máu.

Bệnh nhi:

Tốc độ truyền và thế tích truyền tùy thuộc vào lứa tuổi, cân nặng, tình trạng lâm sàng và tình trạng chuyển hóa của bệnh nhân, việc điều trị và kiểm soát phải được làm bởi bác sĩ có kinh nghiệm trong sử dụng liệu pháp dịch truyền tĩnh mạch ở bệnh nhân nhi.

Chỉ dẫn liều dùng cho bệnh nhân nhi:

Chỉ định	Liều dùng ban đầu	Tốc độ truyền ban đầu*			
		Trẻ sơ sinh non và trẻ sơ sinh	Trẻ sơ sinh và mới biết đi (1-23 tháng)	Trẻ em (2-11 tuổi)	Thanh thiếu niên (12 đến 16-18 tuổi)
Cung cấp năng lượng trong chế độ dinh dưỡng lâm sàng.	• 0-10 kg thể trọng (BW) 100 ml/kg/ngày • 10-20 kg thể trọng (BW) 1000 ml + thêm 50 ml cho mỗi kg thể trọng >10 kg/day • > 20 kg thể trọng (BW) 1500 ml + thêm 20 ml cho mỗi kg thể trọng >20 kg/day	6-11 ml/kg/giờ (10-18 mg/kg/phút)	5-11 ml/kg/giờ (9-18 mg/kg/phút)	4-8 ml/kg/giờ (7-14 mg/kg/phút)	4 ml/kg/giờ (7-8.5 mg/kg/phút)
Phòng và điều trị hạ đường huyết					
Mất nước hoặc mất nước kèm theo có nhu cầu cao carbohydrat					
Dùng để pha loãng các sản phẩm thuốc tương thích	Liều ban đầu: 50 đến 100ml trên liều. Không tùy thuộc vào lứa tuổi. Tốc độ truyền: tùy thuộc vào thuốc pha loãng cùng. Không tùy thuộc vào lứa tuổi.				

LƯU Ý: Thế tích lớn nhất trong liều khuyến cáo nên dùng trong 24 giờ để tránh chứng loãng máu.

Tốc độ truyền khuyến cáo tối đa không được vượt quá quá trình oxy hóa glucose của bệnh nhân, vì điều này có thể gây tăng đường huyết.

Tùy thuộc vào tình trạng lâm sàng của bệnh nhân, tốc độ truyền thấp hơn so với khuyến cáo có thể được sử dụng để làm giảm nguy cơ gây lợi tiểu thẩm thấu không mong muốn.

Khi thuốc được sử dụng để pha loãng các sản phẩm thuốc tương thích khác để truyền tĩnh mạch, chỉ dẫn sử dụng của thuốc pha loãng cùng sẽ quyết định thể tích truyền phù hợp cho mỗi điều trị.

Cách dùng:

Truyền qua tĩnh mạch trung tâm hoặc ngoại vi.

Glucose 10% truyền tĩnh mạch là dung dịch ưu trương.

Áp suất thẩm thấu của dung dịch truyền cuối cùng sau khi pha loãng cùng thuốc khác phải được tính toán khi dùng cho truyền tĩnh mạch ngoại vi.

Việc tăng dần tốc độ truyền nên được xem xét khi truyền các dung dịch chứa glucose.

Các phòng ngừa trước khi dùng thuốc

Kiểm tra cảm quan dịch truyền trước khi sử dụng.

Các dạng thuốc tiêm truyền nên được kiểm tra cảm quan về các tiểu phân và sự đổi màu trước khi truyền, kiểm tra tính nguyên vẹn của bao bì. Chỉ sử dụng nếu dung dịch trong, không có các tiểu phân nhìn thấy, bao bì không hư hỏng. Phải truyền ngay khi cắm bộ dây truyền dịch vào.

Dung dịch phải được truyền với thiết bị vô trùng và sử dụng kỹ thuật vô trùng. Các thiết bị truyền nên có giải pháp ngăn ngừa không khí vào hệ thống.

Việc bổ sung chất điện giải nên theo nhu cầu lâm sàng của từng bệnh nhân.

Các thuốc khác có thể được thêm vào ngay trước khi truyền hoặc trong quá trình truyền thông qua cổng thích hợp. Khi trộn lẫn với thuốc khác, áp suất thẩm thấu cuối cùng của hỗn hợp phải được đo lường trước khi truyền. Việc sử dụng các dung dịch có áp suất thẩm thấu cao có thể gây kích ứng tĩnh mạch và viêm tĩnh mạch.

Việc pha loãng với thuốc khác bắt buộc phải được tiến hành vô trùng và cẩn thận, kỹ lưỡng. Dung dịch sau khi pha loãng phải được sử dụng ngay lập tức. Dung dịch sau pha loãng có thể truyền theo tĩnh mạch trung tâm hay ngoại vi phụ thuộc vào áp suất thẩm thấu.

Kiểm soát:

Việc điều trị nên được thực hiện dưới sự giám sát thường xuyên và cẩn thận. Các thông số lâm sàng và sinh học, đặc biệt nồng độ glucose huyết, cân bằng dịch và điện giải nên được theo dõi thường xuyên và trong suốt quá trình điều trị.

* Chống chỉ định:

- Bệnh tiểu đường mất bù, đái tháo nhạt,
- Hôn mê tăng thẩm thấu,
- Chứng loãng máu, tăng lượng nước ngoài tế bào, tăng dung lượng máu lớn.
- Tăng đường huyết và tăng lactat máu,
- Suy thận nặng (với thiếu niệu /vô niệu),
- Suy tim mất bù,
- Phù (bao gồm phù phổi và phù não) và xơ gan cổ trướng,
- Không dung nạp glucose (như tình trạng rối loạn chuyển hóa).
- Các trường hợp quá mẫn với hoạt chất thuốc.
- Cần xem xét các chống chỉ định có liên quan đến các sản phẩm thuốc pha loãng cùng dung dịch glucose 10%.
- Tình trạng mất nước nhược trương nếu lượng chất điện giải không được bù đắp.
- Bệnh nhân sau tai biến mạch máu não
- Mê sảng do rượu kèm mất nước, ngộ độc rượu cấp.

* Thận trọng:

- Phải theo dõi đều đặn đường huyết, cân bằng nước và các chất điện giải. Cần bổ sung các chất điện giải nếu cần.
- Không truyền dung dịch Glucose cùng với máu qua một bộ dây truyền vì có thể gây tan huyết và tắc nghẽn.
- Truyền Glucose vào tĩnh mạch có thể dẫn đến rối loạn dịch và điện giải như hạ kali huyết, hạ magnesi huyết, hạ phospho huyết.
- Truyền kéo dài hoặc nhanh một lượng lớn dung dịch Glucose ưu trương có thể gây mất nước tế bào do tăng đường huyết.

* Tương tác thuốc:

- Cần tính toán đến ảnh hưởng của dung dịch glucose lên đường huyết và cân bằng nước, điện giải khi sử dụng cho những bệnh nhân đang điều trị các thuốc khác mà có tác dụng kiểm soát đường huyết, cân bằng dịch, điện giải.
- Dùng đồng thời thuốc catecholamine và steroids làm giảm sự hấp thu glucose.

* Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:

- Dùng được cho người mang thai và an toàn đối với người cho con bú

* Tác động khi lái xe và vận hành máy móc:

- Không ảnh hưởng khi lái xe và vận hành máy.

* Tác dụng không mong muốn:

Sử dụng dung dịch truyền Glucose 10% có thể dẫn tới:

- Tăng đường huyết,
- Rối loạn cân bằng dịch (tăng thể tích tuần hoàn),
- Rối loạn điện giải (hạ kali máu, hạ magnesi máu và hạ phosphat máu).

Các tác dụng không mong muốn trong quá trình lưu hành thuốc đã được báo cáo và được liệt kê trong bảng sau theo thứ tự mức độ nghiêm trọng:

Cơ quan bị ảnh hưởng	Tác dụng không mong muốn (theo MedDRA)	Tần suất
Rối loạn hệ thống miễn dịch	Phản ứng phản vệ Quá mẫn (Biểu hiện tiềm tàng ở những bệnh nhân dị ứng với ngô)	Chưa được biết đến (Không thể đánh giá từ những số liệu sẵn có)
Rối loạn chuyển hóa và dinh dưỡng	Rối loạn điện giải Tăng đường huyết Chứng loãng máu Tăng thể tích tuần hoàn	
Rối loạn da và mô dưới da	Đỏ mẩn Phát ban	
Rối loạn chung và tại vị trí tiêm	Ớn lạnh, run rẩy Sốt, phản ứng sốt Nhiễm trùng vị trí tiêm Viêm tắc tĩnh mạch Viêm tắc tĩnh mạch tại chỗ tiêm truyền Ban đỏ tại chỗ tiêm truyền	
Đang điều tra	Đường niệu	

Các tác dụng không mong muốn khác đã được báo cáo khi sử dụng dung dịch tiêm truyền glucose:

- Hạ natri máu, có thể là triệu chứng.
- Suy gan, xơ gan, xơ hóa gan, ứ mật, gan nhiễm mỡ, tăng bilirubin huyết, tăng men gan, sỏi mật, viêm túi mật
- Tắc mạch phổi

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

* Quá liều:

- Sử dụng quá liều glucose có thể dẫn đến tăng đường huyết và đái tháo đường. Quá nhiều glucose trong máu có thể gây khử nước, rối loạn tinh thần, nặng có thể tử vong.
- Trong trường hợp quá liều glucose, chỉ định liều thích hợp Insulin để làm giảm lượng glucose trong máu.

* Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Không dùng thuốc quá hạn dùng

Nếu quan sát thấy dung dịch vẫn đục thì không được sử dụng.

* Tiêu chuẩn chất lượng: USP

* Bảo quản: nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

ĐỂ XA TÂM TAY CỦA TRẺ EM
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN, XIN HỎI Ý KIẾN BÁC SĨ
THUỐC NÀY CHỈ DÙNG THEO ĐƠN CỦA BÁC SĨ

Sản xuất tại:

CÔNG TY CỔ PHẦN FRESenius KABI VIỆT NAM

Khu vực 8 - Phường Nhơn Phú - Tp. Thủ Đức - Tỉnh Bình Định - Việt Nam
Tel: 0256.2221166 * Fax: 0256.2220498